
♦ *HARMONIA FEMININA* ♦



Método

Harmonia Feminina

Guia Completo de Equilíbrio Hormonal

Natural em 21 Dias

Descubra como restaurar sua energia, humor e vitalidade
através da alimentação, rotina e hábitos simples —
sem medicamentos, sem fórmulas caras

Edição 2026

Uma carta para você

Este guia foi criado para você, mulher, que sente que algo não está bem no seu corpo — mas ninguém consegue te explicar exatamente o quê.

Você não está imaginando. Os calorões, a insônia, a irritabilidade, o ganho de peso que não faz sentido, a névoa mental, o cansaço que não passa — são sinais reais de que seus hormônios estão pedindo socorro.

A boa notícia: com mudanças simples na alimentação, no sono e na rotina, é possível restaurar seu equilíbrio hormonal de forma natural.

Este protocolo de 21 dias foi construído com base em estudos científicos e práticas validadas por ginecologistas, nutricionistas e endocrinologistas integrativos.

Você merece se sentir inteira de novo. Vamos juntas?

♥ *Equipe Harmonia Feminina*

Como usar este guia

Este material foi pensado para te acompanhar de forma prática e gentil. Siga o passo a passo abaixo para extrair o máximo de cada página:

- ◆ Leia os capítulos 1 e 2 para entender como seu corpo funciona.
- ◆ Identifique seu perfil hormonal no capítulo 3 antes de seguir adiante.
- ◆ Siga o protocolo de 21 dias detalhado no capítulo 6.
- ◆ Use as receitas, planos alimentares e checklists distribuídos ao longo do guia.
- ◆ Volte sempre que precisar — este é um livro de consulta contínua.

Tempo estimado

- ◆ Tempo de leitura: 45 minutos
- ◆ Tempo diário do protocolo: 15 minutos

Aviso importante

◆ Leia antes de começar

Este material tem caráter educativo e informativo. Não substitui consulta médica, diagnóstico ou tratamento. Antes de iniciar qualquer mudança alimentar ou de rotina, consulte seu ginecologista ou endocrinologista. Se você faz uso de reposição hormonal ou anticoncepcionais, este protocolo é complementar e nunca substitui sua medicação.

“O cuidado consciente sempre começa com informação responsável.”

Sumário

<i>Capítulo 1</i>	Seus Hormônios Explicados		6
<i>Capítulo 2</i>	Descubra Seu Perfil Hormonal		12
<i>Capítulo 3</i>	Alimentação Hormonal		16
<i>Capítulo 4</i>	Sono e Cortisol		24
<i>Capítulo 5</i>	Movimento e Exercício		28
<i>Capítulo 6</i>	O Protocolo de 21 Dias		31
<i>Capítulo 7</i>	Manutenção e Vida Real		37
<i>Capítulo 8</i>	Roteiro da Consulta Inteligente		39



CAPÍTULO 1

Seus hormônios explicados



O que são hormônios

e por que eles comandam sua vida

Hormônios são mensageiros químicos que regulam praticamente tudo no corpo feminino: metabolismo, humor, sono, peso, pele, cabelo, libido, fertilidade e até a forma como você pensa.

Eles são produzidos por glândulas do sistema endócrino: ovários, tireoide, suprarrenais e hipófise.

Quando estão em equilíbrio:

- ◆ Energia constante ao longo do dia
- ◆ Clareza mental e foco
- ◆ Sono restaurador
- ◆ Peso estável
- ◆ Humor equilibrado
- ◆ Pele saudável
- ◆ Libido presente

Quando estão em desequilíbrio:

- ◆ Fadiga crônica
- ◆ Irritabilidade
- ◆ Ganho de peso inexplicável
- ◆ Insônia
- ◆ Queda de cabelo
- ◆ Ansiedade
- ◆ Névoa mental

Os 5 hormônios principais

Parte 1 — Estrogênio e Progesterona

1. ESTROGÊNIO

O hormônio da feminilidade

- ◆ Responsável pelas características femininas, pele, cabelo, ossos, humor e libido.
- ◆ Dominante na primeira metade do ciclo (fase folicular).
- ◆ Em excesso: inchaço, TPM intensa, retenção, ganho de peso no quadril.
- ◆ Em falta: secura vaginal, calorões, perda óssea, envelhecimento da pele.

2. PROGESTERONA

O hormônio da calma

- ◆ Produzida após a ovulação (fase lútea).
- ◆ Prepara o corpo para gravidez, regula o ciclo e traz sensação de calma.
- ◆ Em falta (muito comum): ansiedade, insônia, ciclo irregular, irritabilidade.
- ◆ Depende de gorduras saudáveis, vitamina B6, zinco, magnésio e vitamina C.

Os 5 hormônios principais

Parte 2 — Cortisol, Insulina e Tireoide

3. CORTISOL

O hormônio do estresse

- ◆ Produzido pelas glândulas suprarrenais.
- ◆ Em níveis normais: dá energia pela manhã.
- ◆ Em excesso crônico: rouba a progesterona, acumula gordura abdominal, causa insônia e ansiedade.
- ◆ Inibe o GnRH, podendo causar anovulação e irregularidade.

4. INSULINA

O hormônio do açúcar

- ◆ Regula a glicose no sangue.
- ◆ Resistência à insulina: acúmulo de gordura abdominal, inflamação, SOP, cansaço após refeições.
- ◆ O excesso eleva androgênios e interfere no ciclo menstrual.

5. HORMÔNIOS DA TIREOIDE

T3 e T4 — comandam o metabolismo

- ◆ Regulam metabolismo, temperatura corporal e energia.
- ◆ Hipotireoidismo: fadiga, ganho de peso, constipação, pele seca, cabelo fraco.
- ◆ Hipertireoidismo: perda de peso, ansiedade, taquicardia.

O ciclo menstrual

Sua bússola hormonal mensal

FASE 1: MENSTRUAL (dias 1-5)

- ◆ Todos os hormônios baixos.
- ◆ Modo de renovação.
- ◆ Comum: cólica, fadiga, introspecção.
- ◆ O que fazer: descansar, acolher.

FASE 2: FOLICULAR (dias 6-13)

- ◆ Estrogênio sobe.
- ◆ Energia e criatividade em alta.
- ◆ Pele melhora.
- ◆ O que fazer: iniciar projetos, exercícios intensos.

FASE 3: OVULATÓRIA (dias 14-16)

- ◆ Pico de estrogênio e LH.
- ◆ Auge de energia, libido e sociabilidade.
- ◆ Fertilidade máxima.

FASE 4: LÚTEA (dias 17-28)

- ◆ Progesterona sobe, estrogênio cai.
- ◆ Corpo se prepara para menstruar.
- ◆ TPM na segunda metade.
- ◆ O que fazer: reduzir estímulos.

Por que o desequilíbrio acontece

Existem muitos fatores que podem alterar a delicada conversa entre seus hormônios. Os mais comuns:

- ◆ Estresse crônico (cortisol rouba progesterona).
- ◆ Alimentação inflamatória (ultraprocessados, açúcar, gordura trans).
- ◆ Falta de sono (desregula cortisol e melatonina).
- ◆ Sedentarismo (prejudica insulina e hormônios sexuais).
- ◆ Exposição a xenoestrogênios (plásticos, agrotóxicos, cosméticos com parabenos).
- ◆ Pílula anticoncepcional (suprime ovulação natural).
- ◆ Transições naturais (pré-menopausa, menopausa).
- ◆ Condições médicas (SOP, endometriose, hipotireoidismo).
- ◆ Dietas restritivas.
- ◆ Excesso de cafeína e álcool.

“Reconhecer a causa é o primeiro passo para a cura.”



CAPÍTULO 2

Descubra seu perfil hormonal



Os 3 perfis hormonais

mais comuns nas mulheres

PERFIL 1: DOMINÂNCIA ESTROGÊNICA

- ✦ Excesso de estrogênio em relação à progesterona.
- ✦ Comum em mulheres de 25 a 42 anos.

Sintomas principais:

- TPM intensa
- Inchaço e retenção de líquido
- Dor nos seios
- Ganho de peso no quadril e coxa
- Irritabilidade pré-menstrual
- Fluxo intenso

Causas comuns:

- ✦ Excesso de gordura corporal.
- ✦ Fígado sobrecarregado.
- ✦ Intestino lento.
- ✦ Xenoestrogênios e estresse.

Perfis 2 e 3

PERFIL 2: DÉFICIT DE PROGESTERONA

- ✦ Progesterona insuficiente para equilibrar estrogênio.
- ✦ Comum em mulheres de 36 a 49 anos.

Sintomas:

- Insônia (dificuldade para iniciar o sono)
- Ansiedade e mente acelerada
- Cansaço crônico
- Ciclo irregular e spotting antes da menstruação

Causas: estresse crônico, anovulação, deficiência de B6, zinco e magnésio.

PERFIL 3: RESISTÊNCIA HORMONAL METABÓLICA

- ✦ Resistência à insulina + desregulação do cortisol + declínio hormonal.
- ✦ Comum em mulheres de 43 anos ou mais.

Sintomas:

- Peso na barriga
- Calorões e suor noturno
- Libido baixa
- Perda muscular
- Fadiga extrema

Teste rápido

Qual é o seu perfil?

GRUPO A — Dominância Estrogênica

- | | |
|--|--|
| ☐ TPM intensa | ☐ Inchaço |
| ☐ Peso no quadril | ☐ Fluxo forte |
| ☐ Dor nos seios | ☐ Retenção de líquido |

GRUPO B — Déficit de Progesterona

- | | |
|--|--|
| ☐ Insônia | ☐ Ansiedade |
| ☐ Mente acelerada | ☐ Cansaço crônico |
| ☐ Spotting | ☐ Ciclo irregular |

GRUPO C — Resistência Metabólica

- | | |
|--|---|
| ☐ Peso na barriga | ☐ Calorões |
| ☐ Suor noturno | ☐ Libido zero |
| ☐ Perda muscular | ☐ Fadiga extrema |

O grupo onde você marcou mais sintomas indica seu perfil predominante.



CAPÍTULO 3

Alimentação hormonal



Princípios da alimentação hormonal

“Não é dieta restritiva — é inteligência alimentar.”

PRINCÍPIO 1

Comer para **PRODUZIR** hormônios

Gorduras boas e proteínas de qualidade são matéria-prima essencial para que seu corpo construa estrogênio, progesterona e cortisol em equilíbrio.

PRINCÍPIO 2

Comer para **ELIMINAR** excesso hormonal

Fibras e vegetais crucíferos apoiam o fígado e o intestino na limpeza do excesso de estrogênio circulante.

PRINCÍPIO 3

Comer para **ESTABILIZAR** insulina

Evitar picos glicêmicos protege seus hormônios sexuais e reduz inflamação.

PRINCÍPIO 4

Comer para **REDUZIR** inflamação

Eliminar ultraprocessados e óleos refinados acalma o sistema endócrino e melhora todos os outros pilares.

12 superalimentos hormonais

Parte 1 — Alimentos 1 a 6

1. LINHAÇA

Rica em lignanas (fitoestrógenos que modulam o estrogênio). Ômega-3 anti-inflamatório. 2 colheres de sopa trituradas por dia.

2. ABACATE

Gorduras monoinsaturadas precursoras de hormônios. Potássio, magnésio e vitamina E em abundância.

3. SALMÃO / SARDINHA

Fonte de ômega-3. Reduz inflamação, melhora insulina e diminui a TPM. 2 porções por semana.

4. CRUCÍFEROS

Brócolis, couve-flor e repolho contêm glucosinolatos que ajudam o fígado a metabolizar excesso de estrogênio.

5. SEMENTES DE ABÓBORA

Ricas em zinco (essencial para produção de progesterona) e magnésio.

6. SEMENTES DE GIRASSOL

Selênio e vitamina E — combinação que aumenta a progesterona e protege contra inflamação.

12 superalimentos hormonais

Parte 2 — Alimentos 7 a 12

7. OVOS

Colina para metabolismo hormonal. Proteína completa e fonte de vitamina D.

8. CASTANHAS E NOZES

Gorduras boas, vitamina E e selênio. Lanche perfeito para estabilizar a insulina.

9. FOLHAS VERDE-ESCURAS

Magnésio, ferro e ácido fólico — base de qualquer rotina alimentar hormonal.

10. GENGIBRE E CÚRCUMA

Anti-inflamatórios potentes que apoiam fígado, intestino e digestão.

11. FRUTAS VERMELHAS

Antioxidantes que protegem células hormonais do estresse oxidativo.

12. INHAME

Contém diosgenina, precursor de hormônios sexuais. Aliado especial na menopausa.

8 alimentos que sabotam seus hormônios

Esses são os principais sabotadores hormonais. Reduzir o consumo já é metade do caminho:

- ◆ Açúcar refinado → picos de insulina e inflamação.
- ◆ Ultraprocessados → desregulam a microbiota e inflamam.
- ◆ Óleo de soja e canola → ômega-6 inflamatório.
- ◆ Alcool → sobrecarrega o fígado e reduz progesterona.
- ◆ Cafeína em excesso → eleva o cortisol.
- ◆ Embutidos → xenoestrogênios e excesso de sódio.
- ◆ Soja ultraprocessada → excesso de isoflavonas isoladas.
- ◆ Farinha branca → picos glicêmicos constantes.

“Não é sobre proibir — é sobre escolher melhor 80% do tempo.”

O ciclo das sementes

(seed cycling)

FASE FOLICULAR (dias 1-14)

- ◆ 1 colher de sopa de linhaça triturada.
- ◆ 1 colher de sopa de semente de abóbora.

Por quê: a linhaça modula o estrogênio; a abóbora oferece zinco que apoia a futura produção de progesterona.

FASE LÚTEA (dias 15-28)

- ◆ 1 colher de sopa de gergelim.
- ◆ 1 colher de sopa de girassol.

Por quê: o gergelim apoia a progesterona; o girassol traz selênio e vitamina E.

◆ **Menopausa**

Seguir ciclo lunar: fase 1 na Lua Nova, fase 2 na Lua Cheia.

Resultados em 3 a 4 ciclos de uso consistente.

Plano alimentar modelo

por perfil hormonal

PERFIL 1 — Dominância Estrogênica

- Café:** ovos + couve refogada + abacate
Almoço: salmão + brócolis no vapor + arroz integral
Lanche: castanhas + frutas vermelhas
Jantar: sopa de legumes com gengibre + frango

PERFIL 2 — Déficit de Progesterona

- Café:** vitamina de banana + abacate + cacau + abóbora
Almoço: carne magra + batata doce + salada
Lanche: iogurte + girassol + mel
Jantar: omelete de espinafre + inhame

PERFIL 3 — Resistência Metabólica

- Café:** ovos + abacate + tomate
Almoço: frango + quinoa + legumes com cúrcuma
Lanche: castanhas + chá verde
Jantar: sardinha + salada + linhaça

5 receitas hormonais

prontas em 15 minutos

♦ VITAMINA DA PROGESTERONA

1 banana + ½ abacate + 1 colher de abóbora + 1 colher de cacau + leite vegetal. Bater até ficar cremoso.

♦ BOWL ANTI-ESTROGÊNIO

Couve-flor ralada refogada + ovo pochê + abacate + linhaça + tomate cereja.

♦ SOPA ANTI-INFLAMATÓRIA

Abóbora + gengibre + cúrcuma + pimenta + cebola. Bater e finalizar com azeite cru.

♦ SNACK DA INSULINA

Maçã fatiada + pasta de castanha + canela.

♦ GOLDEN MILK NOTURNO

Leite de coco + cúrcuma + canela + pimenta + mel + gengibre. Aquecer suavemente.



CAPÍTULO 4

Sono e cortisol



Por que você não está dormindo

(e não é culpa sua)

O sono é o pilar mais negligenciado da saúde hormonal feminina. Compreender o que acontece dentro do seu corpo durante a noite muda tudo:

- ◆ O cortisol segue um ritmo circadiano: alto pela manhã, baixo à noite.
- ◆ Estresse crônico inverte esse ritmo — cortisol alto à noite afasta o sono.
- ◆ Pré-menopausa: a queda do estrogênio causa ondas de calor que fragmentam o sono.
- ◆ Progesterona baixa significa dificuldade para iniciar o sono (ela é precursora do GABA).
- ◆ Insulina desregulada gera hipoglicemia noturna, eleva cortisol e te acorda por volta das 3h.

“Dormir bem é tão hormonal quanto comer bem.”

Protocolo de sono hormonal

7 regras essenciais

REGRA 1Janela de sono fixa

Mesmo horário todos os dias (variação máxima de 30 minutos).

REGRA 2Ritual de desligamento

60 min antes desligar telas; 45 min chá calmante; 30 min banho morno; 15 min respiração 4-7-8.

REGRA 3Quarto como santuário

18 a 20°C, escuridão total, sem celular ao lado da cama.

REGRA 4Última refeição 3h antes

Se vier fome: banana com castanhas.

REGRA 5Sol da manhã

10-15 minutos de luz natural nos primeiros 30 min após acordar.

REGRA 6Cafeína somente até 14h

Meia-vida da cafeína é de 5-6 horas no corpo feminino.

REGRA 7Magnésio à noite

200-400mg quelado antes de dormir (sempre com orientação médica).

Respiração e anti-calorão

◆ RESPIRAÇÃO 4-7-8

Inspirar por 4 segundos → segurar por 7 → expirar por 8. Repetir 4 ciclos. Ideal para iniciar o sono.

◆ RESPIRAÇÃO DIAFRAGMÁTICA

Mão na barriga. Inspirar expandindo a barriga, expirar lentamente. 5 minutos, 2 vezes ao dia.

◆ RESPIRAÇÃO ALTERNADA

Fechar a narina direita, inspirar pela esquerda. Alternar a cada respiração. 5 minutos.

Protocolo anti-calorão

- Evite gatilhos: cafeína, álcool, comidas picantes.
- Use camadas removíveis de roupa.
- Durante a crise: respiração lenta + água fria nos pulsos.
- À noite: roupa de cama 100% algodão e copo de água gelada na cabeceira.



CAPÍTULO 5

Movimento e exercício



Exercício que equilibra

vs exercício que desregula

- ◆ Moderado: REDUZ cortisol, melhora insulina e libera endorfinas.
- ◆ Excessivo: AUMENTA cortisol e pode suprimir a ovulação.
- ◆ Regra de ouro: exercício deve dar energia, não tirar.
- ◆ Cortisol alto? Trocar HIIT por caminhada, yoga ou pilates.
- ◆ Musculação moderada é excelente para todas as fases da vida.

Exercício por fase do ciclo:

- Menstrual: caminhada leve, yoga restaurativa.
- Folicular: musculação, corrida, HIIT leve.
- Ovulatória: os treinos mais fortes do mês.
- Lútea: pilates, yoga, caminhada.

Menopausa:

- Musculação 3x por semana.
- Caminhada diária de 30 minutos.
- Yoga 2x por semana.
- Evitar HIIT excessivo.

5 exercícios de 10 minutos

para fazer em casa

1. Sequência de yoga para cortisol

5 posições básicas: criança, gato-vaca, cachorro olhando para baixo, guerreiro suave, cadáver. 2 minutos cada.

2. Caminhada energética

Com respiração consciente: inspirar em 4 passos, expirar em 6. Ritmo confortável, com presença.

3. Treino de força corporal

Agachamentos, prancha, ponte de glúteos, flexão de joelhos. 3 séries de 10 repetições.

4. Alongamento para tensão hormonal

Foco em quadril, abdômen e ombros — regiões que mais acumulam tensão hormonal.

5. Dança livre

10 minutos da sua música favorita. Libera endorfinas, reduz cortisol e melhora o humor instantaneamente.



CAPÍTULO 6

O protocolo de 21 dias



Visão geral do protocolo

O protocolo se divide em três semanas, cada uma com um propósito distinto e cumulativo:

SEMANA 1 (dias 1-7) — LIMPEZA

Eliminar sabotadores hormonais. Iniciar chás, ritual de sono e ciclo das sementes.

SEMANA 2 (dias 8-14) — NUTRIÇÃO

Adicionar superalimentos, exercícios adaptados, respiração e diário de sintomas.

SEMANA 3 (dias 15-21) — HARMONIZAÇÃO

Consolidar a rotina, ajustar o que não funciona e avaliar sua evolução.

Semana 1 — Dia a dia

Limpeza dos sabotadores hormonais

Dia 1 Remover açúcar refinado da rotina.

Dia 2 Trocar óleo de cozinha por azeite + primeiro chá noturno.

Dia 3 Eliminar ultraprocessados e iniciar o ritual de sono.

Dia 4 Reduzir cafeína para 1 xícara até as 14h.

Dia 5 Primeiro dia do ciclo das sementes.

Dia 6 Primeira respiração 4-7-8 antes de dormir.

Dia 7 Avaliação — anote como se sente e o que mudou.

Semana 2 — Dia a dia

Nutrição e adaptação ativa

Dia 8 Adicionar um crucífero ao almoço (brócolis ou couve-flor).

Dia 9 Garantir proteína de qualidade em todas as refeições.

Dia 10 Iniciar exercício adaptado (20 min).

Dia 11 Adicionar gordura boa no café (abacate ou castanhas).

Dia 12 Primeiro Golden Milk noturno.

Dia 13 Respiração diafragmática — 5 min, 2 vezes ao dia.

Dia 14 Avaliação — compare com o que sentia no dia 7.

Semana 3 — Dia a dia

Harmonização e consolidação

Dia 15 Um dia completo seguindo todos os pilares.

Dia 16 Experimentar uma nova receita hormonal.

Dia 17 Aumentar o exercício para 30 minutos.

Dia 18 Avaliar a qualidade do sono — anotar mudanças.

Dia 19 Avaliar o humor e o nível de energia.

Dia 20 Planejar a manutenção da rotina.

Dia 21 Avaliação final — celebrar suas conquistas ♥

Checklist diário do protocolo

Use esta lista todos os dias durante os 21 dias. Marque cada item conforme for cumprindo:

◆ Meu dia hormonal

- ☐ Tomei meu chá hormonal
- ☐ Comi pelo menos 1 alimento hormonal
- ☐ Evitei açúcar refinado e ultraprocessados
- ☐ Fiz meu ciclo das sementes
- ☐ Me exercitei (10 min mínimo)
- ☐ Fiz minha técnica de respiração
- ☐ Segui o ritual de sono
- ☐ Bebi 2 litros de água
- ☐ Registrei meus sintomas
- ☐ Me tratei com gentileza ♥



CAPÍTULO 7

Manutenção e vida real



Depois dos 21 dias

o que manter para sempre

3 hábitos inegociáveis:

- ◆ Ciclo das sementes.
- ◆ Ritual de sono.
- ◆ 1 crucífero por dia.

Recomendações de longo prazo:

- ◆ Exercício 3 a 5 vezes por semana.
- ◆ Revisão mensal do diário de sintomas.
- ◆ Exames hormonais a cada 6 meses.
- ◆ Equilíbrio hormonal não é destino — é prática diária.

Quando buscar ajuda profissional:

- Sangramento muito intenso por mais de 3 meses.
- Sintomas incapacitantes.
- Suspeita de SOP, endometriose ou problemas de tireoide.
- Desejo de iniciar reposição hormonal.
- Sintomas que não melhoram após 2 meses.



CAPÍTULO 8

Roteiro da Consulta Inteligente



Antes da consulta

30 dias que mudam o jogo

A melhor consulta começa em casa. Quando você chega organizada, o médico tem dados para trabalhar — e você deixa de ser "mais uma mulher cansada".

Seu diário pré-consulta (30 dias antes):

- ◆ Data exata de início e fim de cada menstruação.
- ◆ Intensidade do fluxo: nº de absorventes por dia e presença de coágulos.
- ◆ Sintomas físicos por fase do ciclo (TPM, ovulação, menstruação).
- ◆ Sintomas emocionais: humor, choro fácil, ansiedade, irritabilidade.
- ◆ Sono: quantas horas e quantas vezes acordou.
- ◆ Energia: escala 0–10 ao acordar, à tarde e à noite.
- ◆ Apetite, desejos alimentares e libido (0–10) por fase do ciclo.

Leve impresso para a consulta:

- ◆ Exames laboratoriais dos últimos 12 meses.
- ◆ Lista completa de medicamentos, suplementos e dosagens.
- ◆ Histórico hormonal de mãe e irmãs (menarca, menopausa, doenças).
- ◆ Suas 3 prioridades — o que mais quer resolver agora.

◆ Dica de ouro

Peça consulta longa (45–60 min). Avaliação hormonal completa não cabe em 15 minutos.

A linguagem que o médico escuta

traduzindo sintomas em dados clínicos

Sintomas vagos abrem espaço para "é normal", "é estresse", "é da idade". Sintomas mensuráveis e datados fecham esse espaço.

Em vez de... → Diga assim:

"Estou inchada"

→ Retenção hídrica nos 7–10 dias antes da menstruação, com ganho perceptível de peso.

"Estou cansada"

→ Fadiga persistente há X meses, mesmo dormindo 8h, com piora no fim da tarde.

"Minha TPM tá forte"

→ Sintomas pré-menstruais com choro, irritabilidade e ansiedade nos 7 dias antes do ciclo.

"Tô engordando"

→ Ganho de X kg em Y meses, concentrado no abdômen, sem mudanças de rotina.

"Não durmo bem"

→ Acordo 2–3 vezes por noite, principalmente entre 2h e 4h, há X meses.

Use sempre escalas e números:

- ◆ Dor: 0 (nenhuma) a 10 (insuportável).
- ◆ Sangramento: nº de absorventes/dia + coágulos (sim/não).
- ◆ Duração e frequência em dias exatos.
- ◆ Tempo de evolução: "começou há X meses".

Painel hormonal completo

os exames que você deve pedir

Este é o painel completo de avaliação hormonal feminina. Anote, leve impresso e peça que cada um seja solicitado e justificado.

1. Hormônios reprodutivos *(3° ao 5° dia do ciclo, exceto progesterona)*

- FSH e LH (folículo-estimulante e luteinizante).
- Estradiol (E2).
- Progesterona — no 21° dia (ou 7 dias antes da menstruação).
- Prolactina.
- Testosterona total, livre e SHBG.
- DHEA-S.
- AMH (reserva ovariana) — qualquer dia.

2. Tireoide *(qualquer dia, em jejum)*

- TSH, T4 livre, T3 livre.
- Anti-TPO e Anti-TG (avaliam autoimunidade — Hashimoto).

3. Metabolismo e insulina *(jejum de 12h)*

- Glicemia de jejum e insulina basal.
- HOMA-IR (resistência insulínica — calculado).
- Hemoglobina glicada (HbA1c).
- Perfil lipídico completo.

4. Cortisol e estresse

- Cortisol sérico (manhã, 8h).
- Cortisol salivar — curva de 4 coletas no dia.
- Cortisol urinário 24h em casos específicos.

5. Nutrientes e inflamação

- Vitamina D (25-OH), B12 e folato.
- Ferritina (não só hemograma).
- Magnésio eritrocitário (mais preciso que o sérico).
- PCR ultrasensível e homocisteína.

Perguntas certas

o que perguntar (e não esquecer)

◆ Sobre o diagnóstico

- › Qual é sua hipótese principal e o que descartaríamos com esses exames?
- › Em qual fase do ciclo cada exame deve ser coletado para ser confiável?
- › Os critérios de Rotterdam para SOP foram avaliados? (ciclo, andrógenos, ovários)
- › Anti-TPO e anti-TG foram pedidos? Posso ter Hashimoto?

◆ Sobre o tratamento

- › Existe mudança de estilo de vida com evidência para meu caso, antes da medicação?
- › Em quanto tempo devo sentir melhora? Quando devo retornar?
- › Quais efeitos colaterais monitorar e quando devo suspender e ligar?
- › Há contraindicação no meu histórico familiar de câncer, trombose ou AVC?

◆ Sobre reposição hormonal

- › Estrogênio sozinho ou combinado com progesterona — qual minha indicação e por quê?
- › Via oral, transdérmica (gel/adesivo) ou sublingual: qual a mais segura para mim?
- › Hormônios bioidênticos vs sintéticos: qual sua recomendação e por quê?
- › Esquema cíclico ou contínuo? Como afetará meu sangramento?

◆ Antes de aceitar anticoncepcional

- › O anticoncepcional trata a causa ou mascara o sintoma?
- › Quais exames refazer após 3–6 meses de uso?
- › Quais sinais exigem suspensão imediata? (dor no peito, falta de ar, dor nas pernas)

Sinais de alerta

quando insistir e quando trocar de médico

Exigem investigação aprofundada — não aceite "é normal":

- Sangramento entre ciclos ou após relação sexual.
- Fluxo com mais de 7 dias ou troca de absorvente a cada 1h.
- Dor pélvica que impede atividades normais.
- Ganho de peso súbito (mais de 3 kg em 30 dias) sem mudança de hábitos.
- Queda significativa de cabelo em 3 meses.
- Acne adulta acompanhada de pelos no rosto.
- Insônia + suor noturno antes dos 45 anos.
- Fadiga incapacitante por mais de 3 meses.
- Qualquer nódulo palpável (mama, pescoço, axila).

Sinais de que você precisa de segunda opinião:

- Não pediu exames apesar de sintomas claros.
- Prescreveu antidepressivo ou ansiolítico sem investigar hormônios.
- Você se sentiu desrespeitada, julgada ou não ouvida.
- Tratamento sem melhora em 3 meses, sem replanejamento.
- Diagnóstico que te causou estranheza e não foi explicado.

◆ Glossário rápido

DUE — Dominância de estrogênio (E2 alto vs progesterona baixa).

HOMA-IR — Índice de resistência insulínica — acima de 2,5 pede atenção.

AMH — Hormônio antimülleriano — mede a reserva ovariana.

Bioidênticos — Hormônios com estrutura molecular igual aos humanos.

T4L / T3L — Frações livres dos hormônios da tireoide.

Você tem direito a um médico que escute. Se o primeiro não escutou, busque o segundo.

Sua carta de compromisso

consigo mesma

*Eu me comprometo a cuidar do meu corpo
com a gentileza que ele merece.*

*Entendo que meus hormônios não são meus inimigos —
são mensageiros tentando me dizer algo.
A partir de hoje, escolho ouvir.*

- ◆ *Escolho me alimentar com consciência*
- ◆ *Escolho respeitar meu sono*
- ◆ *Escolho mover meu corpo com alegria*
- ◆ *Escolho parar de me culpar*
- ◆ *Escolho começar, mesmo que devagar*

Eu mereço me sentir inteira.

assinatura · data



♥ Obrigada por chegar até aqui

*Você acaba de dar o primeiro passo de uma jornada
que pode transformar sua relação com seu corpo para sempre.*

*Lembre-se: pequenos passos consistentes
geram grandes transformações.*

Você merece se sentir inteira de novo.

*Com carinho,
Equipe Harmonia Feminina ♥*